사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약의 성분 또는 염산세포티암에 의한 쇽의 병력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 이 약의 성분 또는 세펨계 항생물질에 대하여 과민반응의 병력이 있는 환자

2) 페니실린계 항생물질에 대하여 과민반응의 병력이 있는 환자

3) 본인 또는 부모, 형제가 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 나타내기 쉬운 체질을 가진 환자

4) 중증의 신장애 환자

5) 식도통과 장애 환자

6) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)

3. 이상반응

1) 쇽 : 드물게 쇽 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고, 불쾌감, 구내이상감, 천명, 어지러움, 변의, 이명, 발한, 호흡곤란, 혈관부종, 전신홍조 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

2) 과민반응 : 발진, 두드러기, 홍반, 가려움, 발열, 림프선종창, 관절통 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

3) 신장 : 때때로 BUN 상승, 또는 드물게 크레아티닌 상승 등이 나타날 수 있다. 염산 세포티암에서 드물게 급성 신부전 등의 중증의 신장애가 나타날 수 있다는 보고가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 확인될 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

4) 혈액계 : 때때로 빈혈, 호산구 증가다 드물게 과립구 감소, 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다. 염산 세포티암에서 드물게 용혈성 빈혈이 나타날 수 있다는 보고가 있다.

5) 간장 : 때때로 γ-GTP, ALP, LDH의 상승이 나타날 수 있다. AST, ALT상승을 동반한 간기능 장애, 황달이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 확인되는 경우에는 중지하고 적절한 처치를 한다.

6) 소화기계 : 드물게 위막성대장염 등의 혈변을 수반한 중증의 대장염이 나타날 수 있다. 복통, 빈번한 설사가 일어나는 경우에는 즉각 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 할 것. 또 때로 설사, 복통, 구역, 구토, 가슴쓰림, 식욕부진, 위부불쾌감, 위통, 복부팽만감, 변비 등의 증상이 나타날 수 있다.

7) 호흡기계 : 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선이상, 호산구 증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, 호산구성 폐침윤 등이 일어날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코이드의 투여 등의 적절한 처치를 한다.

8) 균교대증 : 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있다.

9) 비타민결핍증 : 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈 혈증, 출혈경향 등) 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있다.

10) 피부 : 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사용해가 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 확인될 경우에는 중지하고 적절한 처치를 한다.

11) 기타 : 때때로 두통, 권태감, 안면 등의 부종, 마비(저림), 흉통이 일어날 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.

2) 쇽이 나타날 수가 있으므로 충분히 문진을 한다.

5. 임부에 대한 투여

임신 중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다.

6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

7. 고령자에 대한 투여

다음 사항에 주의하고 용량 및 투여간격에 유의하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.

1) 생리기능이 저하되는 일이 많아 이상반응이 발현되기 쉽다.

2) 비타민 K 결핍에 의한 출혈경향이 나타날 수 있다.

8. 임상검사치에의 영향

1) 테스테이프반응을 제외한 베네딕트시약, 펠링시약, 클리니테스트에 의한 요당검사에서는 위양성을 나타낼 수가 있으므로 주의한다.

2) 직접 쿰스시험 양성을 나타낼 수 있으므로 주의한다.